



EVALUACIÓN PREANESTÉSICA

Plantilla EVAPRE · Historia clínica de Hospitalización

N° 0201295702

07.OCT.2026 · 09:30 AM

Ámbito: QX

PACIENTE	DOCUMENTO	SEXO / EDAD
OSPINA HENAO CLAUDIA PATRICIA	CC 31902576	Femenino · 49 años
DIAGNÓSTICO	CAMA	MÉDICO TRATANTE
E042 - BOCIO MULTINODULAR NO TOXICO	101-C	Dr. Camilo Grondona

INFORMACIÓN GENERAL

Procedimiento

TIROIDECTOMIA TOTAL CON NEUROMONITOREO DEL NERVIIO LARINGEO RECURRENTE.
INDICACION: BOCIO MULTINODULAR CON NODULO DOMINANTE TIRADS 4 (BETHESDA III) Y COMPRESION TRAQUEAL LEVE.
CIRUJANA: DRA. NATALIA ESCOBAR. SERVICIO: CABEZA Y CUELLO.

ANTECEDENTES

Patológicos	BOCIO MULTINODULAR EUTIROIDEO DESDE 2023. HIPERTENSION ARTERIAL LEVE DESDE 2021, CONTROLADA. OBESIDAD GRADO I (IMC 31). SIN DIABETES, ASMA, EPOC NI APNEA DEL SUEÑO CONOCIDA. STOP-BANG 2 (RIESGO BAJO).
Quirúrgicos	CESAREAS (2000 Y 2005) CON LIGADURA TUBARICA (2005).
Obstetricos	F.U.M.: 23.SEP.2026 (CICLOS REGULARES) GESTACION: 2 PARTO: 0 ABORTO: 0 CESAREA: 2 ECTOPICO: 0
Anestésicos	ANESTESIA RAQUIDEA PARA CESAREAS (2000 Y 2005), SIN COMPLICACIONES. SIN ANTECEDENTE PERSONAL NI FAMILIAR DE HIPERTERMIA MALIGNA.
Tóxicos	NIEGA TABAQUISMO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
Alérgicos	NIEGA ALERGIAS A MEDICAMENTOS, LATEX Y ALIMENTOS.
Farmacologicos	LOSARTAN 50 MG C/24 H (SUSPENDER 24 HORAS ANTES DE LA CIRUGIA). NO USA ANTICOAGULANTES NI ANTIAGREGANTES.
Transfusional	NIEGA TRANSFUSIONES PREVIAS.

LABORATORIOS

HB	HCTO	Plaquetas
13,8 g/dL	41 %	268.000 /mm³
Leucocitos	TP	PTT
7.200 /mm³	12,1 s (CONTROL 12,0)	29 s (CONTROL 30)
INR	Glicemia	HbA1c
1,0	94 mg/dL	5,6 %
BUN	Creatinina	Ionograma
13 mg/dL	0,8 mg/dL (TFG 92 mL/min)	Na 140, K 4,2, Cl 103
Albúmina		
4,2 g/dL		

Parcial de orina

SIN ALTERACIONES. EMBARAZO DESCARTADO (BHCG NEGATIVA).

Gases arteriales

NO SE REQUIEREN GASES ARTERIALES. SPO2 98 % AL AIRE AMBIENTE.

Otros (química sanguínea)

TSH 1,8 mUI/L (0,4-4,0)
T4 LIBRE 1,1 ng/dL (0,8-1,8)
CALCIO TOTAL 9,4 mg/dL (8,6-10,2)
EUTIROIDISMO Y CALCEMIA NORMAL.

EKG

RITMO SINUSAL A 72 LPM, EJE NORMAL, SIN ISQUEMIA, NI BLOQUEO DE RAMA. QTc 410 ms.

RX Torax

SIN INFILTRADOS NI DERRAME. DESVIACION TRAQUEAL LEVE A LA DERECHA. SILUETA CARDIACA NORMAL.

Otros (imagenes dx)

ECOGRAFIA DE TIROIDES: BOCIO MULTINODULAR, NODULO DOMINANTE EN LOBULO DERECHO DE 2,4 CM (TIRADS 4).
TAC DE CUELLO: DESPLAZAMIENTO TRAQUEAL LEVE SIN ESTENOSIS CRITICA (LUZ > 10 MM). SIN EXTENSION RETROESTERNAL.

EXAMEN FÍSICO

Sensorio ALERTA, ORIENTADA, GLASGOW 15/15	TA mmHg 124/78	FC 72	FR 16	T °C 36,6	Peso kg 82	Talla cm 162	IMC 31,2
---	--------------------------	-----------------	-----------------	---------------------	----------------------	------------------------	--------------------

Protesis dental	No
Lentes	No
Apertura oral	≥ 3 cm
DTM	6 - 6,5 cm
Distancia externomentoniana	≥ 12 cm
Circunferencia de cuello	≥ 40 cm
Test de la mordida	Clase I
Distancia interincisivos	> 4 cm
Mallampaty	Clase II
Cabeza y O. de S.	PUPILAS ISOCORICAS, NORMOREACTIVAS. MUCOSAS ROSADAS, HUMEDAS, ANICTERICAS. DENTADURA NATURAL COMPLETA, SIN PIEZAS FLOJAS.
Cuello y cabeza	BOCIO PALPABLE, NODULAR, MOVIL CON LA DEGLUTICION, SIN ADENOPATIAS. TRAQUEA DESVIADA LEVEMENTE A LA DERECHA. EXTENSION CERVICAL CONSERVADA. SIN ESTRIDOR NI DISFONIA.
Cardiororacico	RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. MURMULLO VESICULAR CONSERVADOS, SIN RUIDOS SOBREAGREGADOS
Abdomen	BLANDO, NO DOLOROSO A LA PALPACION, SIN MASAS NI MEGALIAS. PERISTATISMO POSITIVO
GU	SIN ALTERACIONES.
Extremidades	PULSOS DISTALES SIMETRICOS ++. LLENADO CAPILAR < 2 SEGUNDOS. SIN EDEMAS
Neurologico	GLASGOW 15/15. SIN DEFICIT MOTOR NI SENSITIVO.

VALORACIÓN DEL RIESGO

Indice de Karnofsky	100. No hay quejas: no hay evidencia de enfermedad
Estado físico ASA	ASA II - Enfermedad sistémica leve
NYHA	Clase I
LEE ThRCI (Factores de riesgo)	Ninguno
LEE ThRCI (Puntos)	0 puntos
LEE Revisado (Factores de riesgo)	Ninguno
LEE Revisado (Clase)	Clase I
Capacidad funcional	Excelente (> 10 METs)

PLAN ANESTÉSICO

Tipo de anestesia	General
UCI postquirúrgica	No
Hemoderivados	NO REQUIERE RESERVA DE HEMODERIVADOS. GRUPO Y RH EN HISTORIA: A POSITIVO.

Recomendaciones

- 1. AYUNO 8 HORAS SOLIDOS, 6 HORAS LIQUIDOS CLAROS
- 2. SE EXPLICAN RIESGOS Y BENEFICIOS DE LA ANESTESIA GENERAL (INCLUIDA LA DISFONIA TRANSITORIA POR INTUBACION), SE RESUELVEN DUDAS Y SE FIRMA CONSENTIMIENTO INFORMADO
- 3. SUSPENDER LOSARTAN 24 HORAS ANTES DE LA CIRUGIA
- 4. EUTIROIDISMO Y CALCEMIA NORMAL CONFIRMADOS (TSH, T4 LIBRE, CALCIO); REPETIR CALCIO A LAS 24 HORAS DEL POSTOPERATORIO
- 5. NEUROMONITOREO DEL NERVIO LARINGEO RECURRENTE: TUBO ENDOTRAQUEAL CON ELECTRODOS Y RELAJANTE MUSCULAR DE ACCION CORTA, SIN REPETIR DOSIS
- 6. PROFILAXIS DE NVPO (MUJER, NO FUMADORA, OPIOIDES POSTOPERATORIOS): DEXAMETASONA 8 MG Y ONDANSETRON 4 MG IV
- 7. POSTOPERATORIO: VIGILAR HEMATOMA CERVICAL Y SIGNOS DE HIPOCALCEMIA

Análisis

PACIENTE FEMENINA DE 49 AÑOS, ASA II (HTA CONTROLADA, OBESIDAD GRADO I), PROGRAMADA PARA TIROIDECTOMIA TOTAL. RIESGO CARDIOVASCULAR BAJO (LEE REVISADO CLASE I, NYHA I, > 10 METS), SIN NECESIDAD DE ESTUDIOS ADICIONALES. VIA AEREA SIN PREDICTORES DE DIFICULTAD (MALLAMPATI II, APERTURA ORAL > 3 CM, DTM 6-6,5 CM); LA DESVIACION TRAQUEAL LEVE Y EL CUELLO DE 40 CM O MAS JUSTIFICAN TENER VIDEOLARINGOSCOPIO DISPONIBLE. SE PLANEA ANESTESIA GENERAL BALANCEADA CON INTUBACION OROTRAQUEAL Y MONITORIA ESTANDAR ASA CON CAPNOGRAFIA. APTA PARA EL PROCEDIMIENTO CON LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES.

VARGAS LOZANO JUAN PABLO

ANESTESIOLOGÍA · Médico

Firmado electrónicamente

07.OCT.2026 · 09:30 AM
Registro N° 0201295702